

ANGIOEDEMA HEREDITARIO

Carmen Luz Avendaño Monje, José María García Ruiz de Morales, Sara María Calleja Antolín.

INTRODUCCIÓN

Angioedema (AE) es la extravasación de fluido intravascular a dermis, tejido subcutáneo y/o submucoso.

Angioedema hereditario (AEH), con o sin déficit de C1 Inhibidor, es una enfermedad rara. Se caracteriza por ataques de angioedemas no inflamatorios, transitorios y recurrentes. La afectación de vía aérea superior tiene un riesgo de muerte del 25% sin el tratamiento específico. El mediador es la Bradiquinina, resultado de la activación excesiva de la vía calicreina-cinina.

Etiología

El AEH se debe a una mutación en el gen que codifica para el Inhibidor de la C1 esterasa (C1 Inhibidor), lo que genera bajas concentraciones plasmáticas de C1 Inhibidor (Tipo I) o concentraciones normales con una función alterada (Tipo II). El Tipo III, es causado por una mutación en el gen del factor XII de la coagulación.

Es importante considerar que existen otras causas de AE mediado por Bradiquinina.

Otras causas de Angioedema mediado por Bradiquinina

- Causas adquiridas
- Trastorno linfoproliferativo
- Anticuerpos dirigidos contra C1-Inhibidor
- Drogas
- Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA)
- Antiinflamatorios no esteroides (AINE)
- Estrógenos.
- Antibióticos
- Antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA-II)
- Inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4)
- Activadores recombinantes del plasminógeno tisular (r-TPA)

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

Antecedentes de episodios anteriores, diagnóstico previo de AE, antecedentes familiares de AE, edad de inicio, posibles factores desencadenantes, comorbilidad de base (Enfermedades autoinmunes) y las características clínicas del episodio actual.

Exploración física

Determinar gravedad, explorando vía aérea, tensión arterial, frecuencia cardiaca, respiratoria y saturación de oxígeno.

Sintomatología

Edema y tumefacción de instauración gradual, que puede persistir 48-72 Horas. Difiere clínicamente del AE mediado por histamina, Tabla 2.

Tabla 2 AE mediado por bradiquinina

- Ausencia de urticaria
- Ausencia de prurito
- Ataques recurrentes
- Historia familiar
- Fármacos (IECA, ARA II, DPP-4, estrógenos)
- Morbilidad (tumores, linfomas y enfermedades autoinmunes)
- No responde a tratamiento con antihistamínicos, corticoides y/o adrenalina.

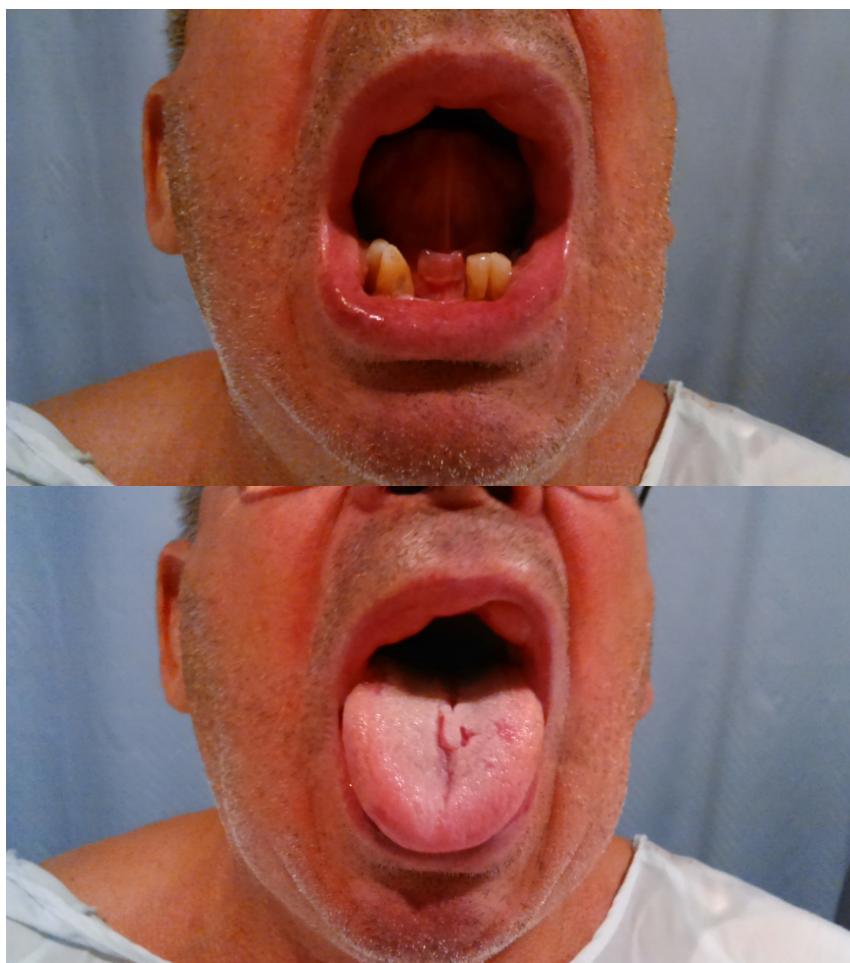
Características clínicas según localización

Piel: El AE no duele, no se acompaña de prurito, ni fóvea, ni urticaria. Puede afectar manos, pies, cara, etc. de forma asimétrica.

Orofaríngea: Angioedema de labios, lengua, úvula, faringe, y laringe, es potencialmente mortal. Sospechar ante la aparición de disfagia, sensación de cuerpo extraño, ronquera o disfonía, estridor y/o disnea.

Gastrointestinal: Dolor abdominal difuso, vómitos y/o diarrea.

Cerebral: Cefalea intensa, sensación de opresión cefálica y/u ocular, visión borrosa, diplopía, mareos, vértigo, etc.



Angioedema de labios y lengua.

Pruebas complementarias

- Hemograma y bioquímica básica.

- Gasometría arterial, si existe compromiso respiratorio.
- Electrocardiograma.
- Radiografía de tórax.
- Radiografía simple de abdomen, si existe dolor abdominal.
- Ecografía abdominal, según clínica.
- Laringoscopia indirecta. Identifica pacientes de alto riesgo.

- Si existe sospecha clínica de Angioedema mediado por bradiquinina, derivar a Inmunología.

TRATAMIENTO

Medidas no farmacológicas

- Valorar vía aérea segura
- Estabilizar al paciente

Medidas farmacológicas

1. Concentrado Plasmático De Inhibidor De La C1 Esterasa Humano

Bérinert®

- Presentación: 1 vial liofilizado 500 UI, 1500 UI
- Dosis: 20 UI/ Kg peso.
- Administración: bolus IV lento, pasar en 10 minutos o en perfusión a 4 ml/min.
- Tiempo medio de respuesta: 48 minutos
- Si, respuesta incompleta, repetir dosis a los 60 minutos
- Indicado en adultos y pacientes pediátricos

Cinrzye®

- Presentación: 2 viales liofilizados 500 UI
- Dosis: 1000 UI dosis fija
- Administración: bolus IV lento a una velocidad de 1 ml/min.
- Tiempo medio de respuesta: 30 minutos
- Si, respuesta incompleta, repetir segunda dosis a los 60 minutos.
- Indicado en mayores de 12 años

2. Antagonista Competitivo Selectivo De Los Receptores Tipo 2 De Bradiquinina (B2R)

Acetato de Icatibant (Firazyr®)

- Presentación: 1 jeringa precargada de 30 mg/3ml
- Dosis: 30mg
- Administración: inyección subcutánea en zona abdominal, lentamente debido al gran volumen a administrar.
- Tiempo medio de respuesta: 2 horas
- Si, respuesta incompleta, hasta un máximo de 3 viales en 24 horas, administrada al menos con 6 horas de diferencia.
- Indicado en adultos.
- Contraindicado: Cardiopatía isquémica, angina inestable o infarto agudo de miocardio, ACVA isquémico reciente, embarazo, lactancia y niños.
- Si evolución lenta, dejar en observación y realizar interconsulta a inmunología.

BIBLIOGRAFÍA

- M. Maurer, M. Magerl et al. The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema—The 2017 revision and update. *Allergy*. 2018; 1–22.
- Jonathan AB, Paolo C, Thomas KH, John H. Angioedema in the emergency department: a practical guide to differential diagnosis and management. *Int J Emerg Med*. 2017; 10:15.
- Laurence B, Audrey L, et al. Traitements des angioedèmes héréditaires: recommandations du centre de référence national des angioedèmes (consensus 2014 de Bordeaux). *Presse Med*. 2015; 44: 526–532.
- Stephen B, Jacquie B, et al. Canadian hereditary angioedema guideline. *Allergy, Asthma & Clinical Immunology*. 2014; 10:50.
- Hilary L, Marco C. Hereditary angio-oedema. *Lancet*. 2012; 379: 474–81.